

Krankheit	Anamnese	Status	Prozedere / Untersuchungen	Therapie	Kommentar
Impfanamnese	Impfungen gemacht + wann welche, Kinderkrankheiten, Einstellung d. Eltern, Angst abbauen	Lymphknoten, Haut (Exanthem), Mund (Zunge, Tonsillen, Rachen), Lunge, Herz, Abdomen	Impfungen empfehlen: <u>Ab 2 Mt.:</u> Diphtherie/Tet/Polio, H. influenza, Hep. B, Pneumokokken, Keuchhusten <u>Ab 12 Mt.:</u> MMR, Meningokokken C, <u>11-15 J.:</u> Varizellen*	Kinderkrankheiten (Masern, Mumps, Röteln, Varizellen, Keuchhusten, Diphtherie, Scharlach, 3-T-Fieber) Impfungen: MMR, Varizellen, Tetanus/Polio/Diphtherie, Keuchhusten, H. influenzae Typ B (Grippe), Pneumokokken, Meningokokken C, *weil fast alle Kinder Varizellen durchmachen + relativ harmlos >impft mit 11-15J. nur jene, die Seronegativ sind.	
Ernährungsanamnese/Stillen	Siehe CST-ZF + Prakti-ZF				
Entwicklung	Siehe CST-ZF				
Status GEBS (Frühgeborener)	Vorkehrungen: Wärmebett mit Wärmelampe, O2, Tücher, etc.	Nach Geburt sofort: In warmes Tuch hüllen + trocknen, Bett/Wärmelampe, APGAR, Pulse + Rekap, Präkordium, Herz-Lunge, Abdomen inkl. Darmgeräusche	Biox, BE (Nabel-pH, Blutgase) Den Eltern geben Geburtszeit erfassen		
Neugeborenenstatus/ Wochenbett (3. Tag i.d.R.)	JL, AZ (Verhalten, Weinen, Spielen, Schreien, Trinken, Essen, Ausscheidung, Apathie, schläfrig), B-Symptome Schwangerschaft -Anamnese Geburts -Anamnese Ernährung, Stillen Impfungen PA, FA, Allergien, Medis, Soziales	Perzentilen (KU, Gewicht, Grösse), Inspektion (Reifezeichen, Zyanose, Dysmorphie-Zeichen, Haut), Herz (Präkordium, Schwirren, Auskult. Inkl. Carotis, Pulse ingual + brachial, Rekap.), Lunge (Atemnotzeichen, Auskult.), Abdomen (Palpation, DG's, Milz, Leber), Neuro (Hand- + Fussgreifreflex, Saugreflex, Schreitreflex, Moro, M-Tonus), Bewegungsapp. (Tonus, Gelenke bewegen, alle Knochen da? Wirbel?), Kopf (Lid-, Gaumenspalte, Fontanellen, Ohren, Augen inkl. Fundoskopie), Genitale (Hoden-Deszension), Bauchlage (Nieren, WS, Spina bifida, Anus)	OAE Schädel + Becken-US BE/Guthrie-Screening Vit. D + Vit. K Stillberatung anbieten Pädiater organisieren	Reifezeichen: Lanugo-Haare nur an Schulter + Oberarmen, subkutan Fett, Nägel überragen Fingerkuppen, Gefaltete Fusssohlen, Grosse Schamlippen überdecken Kleine, Hoden-Deszensus, >48 cm, >2500g, Nasen- + Ohrenknorpel Atemnotzeichen: Einziehungen, Tachypnoe, Nasenflügeln, Stöhnen, Stridor, Giemen, Zyanose SS- + Geburtsanamnese: s. unten	
Untersuchung Säugling	JL, AZ (Verhalten, Weinen, Spielen, Schreien, Trinken, Essen, Ausscheidung, Apathie, schläfrig), B-Symptome Schwangerschaft -Anamnese Geburts -Anamnese Ernährung, Stillen Impfungen PA, FA, Allergien, Medis, Soziales	Perzentilen (KU, Gewicht, Grösse), Inspektion (Reifezeichen, Zyanose, Dysmorphie-Zeichen, Haut), Herz (Präkordium, Schwirren, Auskult. Inkl. Carotis, Pulse ingual + brachial, Rekap.), Lunge (Atemnotzeichen, Auskult.), Abdomen (Palpation, DG's, Milz, Leber), Neuro (NG-Reflexe noch da? M-Tonus, Sens., BSR-, PSR-Reflex), Bewegungsapp. (Tonus, Gelenke bewegen), Kopf (Fontanellen, Ohren, Augen inkl. Fundoskopie), Genitale (Hoden-Deszension), Bauchlage (Nieren, WS)			SS- + Geburtsanamnese: s. unten Siehe CST-ZF

Siehe CST-ZF	Untersuchung Kleinkind Anamnese: <u>AZ</u> (Spielen, Schreien, Trinken, Urin, Stuhl, Schlaf, etc.), <u>Perzentilen</u> , Ernährung, <u>Impfungen/Kinderkrankheiten</u> , Schlaf, B-Symptome, <u>Entwicklung</u> (Sprache, Fremdeln, Motorik, Zähne, Kognition) + Schulanamnese PA, FA, Allergien, Medis, Soziales Internistischer Status: <u>Perzentilen</u> (Gew., Grösse, KU), Inspektion, Kardiostatus, Pneumostatus, Abdomen, Neurostatus, HNO (Otoskopie, Gehör, Rachen, Mund, Nase, Hals), Bewegungsapparat, LK + SD		Untersuchung Jugendlicher Anamnese: JL, Perzentilen, Ernährung, <u>Impfungen/Kinderkrankheiten</u> , Schlaf, B-Symptome, Wachstum + Entwicklung (Sprache, Fremdeln, Kognition) + Schulanamnese, <u>Sexualität</u> PA, FA, Allergien, Medis, Soziales Intersitischer Status: <u>Perzentilen</u> (Gew., Grösse, KU), Inspektion > <u>Tannerstadien/Sek. Geschlechtsmerkmale</u> ! Kardiostatus, Pneumostatus, Abdomen, Neurostatus, HNO (Otoskopie, Gehör, Rachen, Mund, Nase, Hals), Bewegungsapparat, LK + SD		Dysmorphiestatus Tiefsitzende Ohren, grosse Zunge, Behaarung Gesicht/Körper, zu viele od. zu wenig Finger/Zehen, Hyperakt. Präkordium, Hypertelorismus, Epikanthus, 4-Finger-Furche, plumpe Finger Sek. Geschlechtsmerkmale: Schambehaarung, Achseln, Muskelaufbau M: Penis- + Hodenvergrösserung, Stimmbruch F: Labienvergrösserung, Mamma-Bildung, Menarche
Frühgeburtlichkeit	AZ Kind (Atmung, Schlaf, Schreien, Trinken, Urin, Stuhl...) Geburts-Anamnese (SAFT, Entbindungsart, APGAR) SS-Anamnese (Lungenreifung, RF's) Gefahren: Lunge: ANS, Broncho-pulm. Dysplasie ZNS: Blutungen, Bradyk-Apn.-Sy, Cerebralparese, ADHS, visuelle + aud. Störungen, Kongition, Motorik GIT: NEC/Ileus Infekte:	Perzentilen Inspektion: Ikterus, Reifezeichen Lunge: Atemnot-Zeichen Restl. Status: s. CST + oben	Biox, aBGA Exkurs: Neugeborenenikterus Dx via Coombstest (AK gg. Rh+ v. Kind), Phototherapie, AK (falls nicht genug), Austauschtransfusion (wenn s. starker Ikterus), Stillpause nicht indiziert, physiolog. Ikterus beginnt frühestens 24h postpartal und dauert max. 8-14 T. und nicht mehr als 250 mikromol/l	Pränatal: Tokolyse, B-Mimetika, Ca-Blocker, Magnesium, Lungenreifung (Cortison) Postpartal: Vitamine, Steroide, Inhalationen,	SS-Anamnese: SAFT, Alter Mutter, Anzahl Kinder, Wunschkind? Alk, Rauchen, Drogen, Erkrankungen, Medis, Soziales, Partner, Dauer SS).... Geburts-Anamnese: SAFT, Entbindungsart, Kindsmasse, APGAR, Fruchtwasserfarbe, BG.... Auslöser: Stress, Armut, <16J., Infekte, Anämie, Süchte/Drogen, Unterernährung, Vorz. Blasensprung, Plazentainsuff., Mehrlinge, Fehlbildungen...
Fieber	Tachykardie, Husten, Halsweh, Schnupfen, Kopf-Sz., Bauchweh, Erbrechen, Diarrhoe, Dysurie, Ohren-Sz., Arthritis, Tagesschwankungen, Messmethode, Exanthem, Juckreiz, AZ/Verhalten, Schlaf, Kranke in Fam./Umfeld, Urin/Stuhl, Appetit, Medis, Kinderkrankheiten	Neuro: Meningismus prüfen (Nackensteifigkeit, Kernig/Lasegue-mässig), Pupillen, Sens., Hirnnerven AZ: Peripherie warm? Farbe, Turgor/Schleimhäute, Verhalten HNO (Mundhöhle, Rachen, Ohr), Lunge Haut (Exanthem) GIT/Abdomen Nierenloggen Lymphknoten Gelenke	Vitalparameter (Puls, BD, Peripherie), Fiebertmessungen U-Status + Urinkult (bei HWI + Bauchorgane) NPS, Rachenabstrich, Streptotest , bei V.a. auf Infekt obere Atemwege BE (CRP, LK, + je nach Verdacht) LP bei V.a. auf Meningitis Ev. Bildgebung (US bei inneren Organen, CT bei Mastoiditis, Rx bei Pneumonie, Szintih bei Osteomyelitis)	Fiebersenkende Medis Th. je nach Ursache Genug Trinken Sepsis-Workup wenn: akut hohes Fieber + kein Infektfokus + ev. schlechter AZ >BE (CRP, Blutbild), Blutkultur, Th-Rx*, U-Status, LP* *nur wenn schlechter AZ	DD: Infekt obere Atemwege, Fieberkrampf, Kinderkrankheiten, 3-Tage-Fieber, Pneumonie, Gastro-E./GIT, HWI, O. media/Mastoiditis, Osteomyelitis, Meningitis, Sepsis.... Status febrilis: >7 T. NPS: eher f. Viren, Rachenabstrich (bakt.), Streptoest (Strep. A) 3-T-Fieber: meist zw. 6-24 Mt., Herpes-Virus, nach 3T. Fieber Exanthem, selbstlimitierend, sympt. Th.

Kinderkrankheiten	Impfungen, welche Kinderkrankheiten durchgemacht? Fieber, Exanthem (Details erfragen), Juckreiz, AZ, Ernährung/Appetit, Diarrhoe, Erbrechen, Kopf-Sz., Arthralgie, Bauch-Sz.	Haut + Schleimhäute + Kopf/Gesicht Lymphknoten Abdomen Mund/Rachen/Tonsillen Gelenke Koplik-Flecken: rötl. Punkte Wangeninnenseite <u>Achtung</u> auch <u>Exanthem</u> bei: Parvovirus B19 (Ringelröteln), Entero- + Adenoviren, HHV-6 (3-d-Fieber) <u>Kawasaki-Sy</u> : whschl. infektiöse Ursache >akute Vaskulitis mittlerer Arterien <u>Diagnostik</u> i.d.R. Klinisch! Selten Serologie.	Masern-Virus : <u>Prodromi</u> (Fieber, Husten, RS, ev. Koplikflecken!...) dann <u>MPE</u> (konfluierend, Beginn Gesicht, Verlauf nach distal), <u>Komplik.</u> <u>ZNS</u> , <u>Pneumonie</u> u.a.; ev. Serologie (IgM), NPS, Rachenabstrich; <u>symptom.</u> <u>>Vit.</u> <u>A</u> falls <u>Mangel</u> , <u>Ribavirin</u> falls <u>ZNS-Komplik.</u> Röteln-Virus : ev. leichte Prodromi, <u>Exanthem</u> (initial Gesicht + dann distal, <u>feinmakulös</u> , ev. Juckreiz), LK, <u>Arthralgie</u> ; Komplik. nur wenn <u>kongenital/SS</u> ; ev. Serologie (IgM), <u>symptomatisch</u> Ringelröteln-Virus : Exanthen (<u>Ohrfeigengesicht</u> + v.a. Extremitäten, <u>girlandenförmig/retikulär</u> , stärker bei <u>Stress/Sport/Emotion/Wärme</u>), Arthralgien, Komplik. falls <u>Primoinfektion in SS</u> ; Serologie, PCR; <u>symptomatische Th.</u> Varizellen VZV : <u>Prodromi</u> , Fieber, <u>MPE</u> (Beginn <u>Kopfhaut</u> >Stamm >Extremitäten + Schleimhaut, Vessikel > <u>Krusten</u>), <u>Juckreiz</u> ; klin. Dx od. Bläschen-Abstrich; Komplikationen > <u>bakt. Superinfektion</u> , <u>H. Zoster</u> ; <u>sympt. Th.</u> , <u>Acidovir</u> nur wenn <u>H. Zoster im Gesicht od. Immunsuppr. Od. Kind >12J./Erw.</u> Scharlach-Strep. A : <u>Streptokokken-Angina</u> (<u>schlagartiger</u> Beginn, hoch Fieber, Kopf- + Bauch-Sz., Erbrechen/Übelkeit, LK, <u>KEINE</u> grippalen Prodromi, geröteter Pharynx, Himbeer-Zunge, geschwollene Tonsillen, Petechien am weichen Gaumen), <u>Exanthem</u> (<u>feinpapulös</u> /Schmurgelpapier, initial Gesicht, v.a. Beugefalten, Schuppen in 2. Woche, <u>Mund-3-Eck ausgespart</u>); Komplik. > <u>Peritonsillarabszess</u> , <u>rheumat. Fieber</u> , <u>GN</u> ; Strepto-Test; <u>orale AB</u> . 3-Tage-Fieber-HHV-6 : hoch Fieber, Fieberkrämpfe z.T., <u>flüchtiges stammbetontes Exanthem nach Fieberabfall</u> (MPE), LK, fast nur Kleinkinder (<u>6-48 Mt.</u>); Klinik, selten Serologie; <u>symptomatisch</u> Kawasaki-Syndrom : Fieber (> <u>5T.</u>) + konjunkt. Inj., Exanthem, Veränderungen Lippen/Mundmukosa, LK, Extremitätenschwellungen; klinische Dx (<u>Symptomkomplex</u>); <u>hochdosiert AK i.v.</u>		
HWI	Fieber, Sz./Brennen beim Wasserlösen, häufiges Wasserlösen, Urin-Farbe, Blut, Menge, Trübung, Trinken, AZ, Intimpflege, Trinkverhalten, Opstipation Darm, wie oft Pinkeln	AZ (Turgor/Schleimhäute) Abdomen (Palpation, Auskultation , Leber, Milz) Nierenlogen Genitale Lymphknoten	U-Status (mit Sediment >EC, LK, Bakt.) + Urikult BE (CRP, LK, Kreatinin) US (immer) MCUG (nach Infekt): falls <3J. od. wenn >3J. und auffälliger US od. rezidiv. HWI's (mit Pyelonephritis).	AB (<6Mt. i.v., >6 Mt. p.o. möglich; 10-14T. ca.) Viel Trinken!	U-Status: EC's, LK, Bakterien, Nitrit im Sediment. Ideal Mittelstrahlurin, sonst Säckli-Urin. Pyelonephritis : CRP hoch, Flanken-Sz.
Husten / Infekt obere Atemwege	Trocken, Feucht, Sz., Auswurf, bellend, Schnupfen, Halsweh, Ohrenweh, Fieber, AZ, Kopf-Sz. (beim Bücken), NAB/Dyspnoe, Hyposmie, Allergien	Lunge : Auskult. + Perkussion HNO : Ohren, Nase, Rachen/Mund/Zunge Lymphknoten Haut (Exanthem)	BE (CRP + LK) <u>Schnupfen</u> <u>NPS</u> <u>Angina/Tonsillitis od. Pharyngitis</u> Abstrich + Streptotest <u>Mononukleose</u> BE (Leberwerte + LZ), Serologie (IgM) <u>Scharlach</u> : Streptotest Bei RS keine BE nötig, fast immer viral	<u>CRP + LK normal >viral od. Mononukleose >symptomatische Therapie</u> - Husten: Sirup (<u>Solmucalm</u>) - Halsweh: <u>Lutschtabletten</u> , <u>Spray</u> , <u>Gurgeln</u> - Schnupfen: <u>Otrivin</u> , <u>Steroidspray</u> , <u>NaCl</u> -Spülungen - Generell: NSAR - Allergisch: <u>top. Steroide</u> od. top. <u>Antihistaminikum</u> <u>CRP + LK hoch >bakteriell od. wenn Streptotest positiv</u> - AB + sympt. Th.	

Asthma	Anfälle, Husten, Dyspnoe, Pfeiffen/Giemen, Sz., Sekret, bei Belastung, saisonal/Frühlung od. perennial, top. Veranlagung (Allergien, Konjunktivitis, Rhinosinusitis, Neurodermitis), FA Trigger: Belastung, Infekte, Allergien, Medis, tox. Stoffe, kalte Luft	Lunge (Auskultation >verlängertes Exspirium/Giemen, ev. trockene RG's, Perkussion >hypersonor, Atemnotzeichen, Freq., Herz (Tachyk., pulsus Paradoxus) HNO LK	LUFU (FEV1 + VC tief) Ev. Labor (Eosinophilie) Instruktion: Inhalationsinstruktion Peak-Flow Allerg. Abklärung bei Verdacht	1. Peak-Flow-Protokoll 2. Allergietests/Karenz 3. Ventolin mitgeben f. Anfälle 4. Simbicort (Steroid + B2-Mim. als Lanzeit-Th.) 5. bei rezidiv. Resp. Infekten Impfungen (Pneumok. + H. infl.) + Bronchovaxom	
Bauch-Sz./akutes Abdomen	Schmerzen (7 Dimensionen genau erfragen, Sz/Erleichterung bei Stuhlgang, etc.), AZ, Schonhaltung, Schlaf, Fieber, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Wind, Blähung, Stuhl- + Urin, Blutverluste, Appetit, Ernährung, Kopf-Sz., Schwindel, Arthritis, Gewichtsverlust, nächtliches Erwachen, B-Symptome, Wachstumsrückstand Trigger: Trauma, Medis, Kinderkrankheiten, Umfeld krank, Psyche/Soziales/Schule, Verdorbene Speisen	Inspektion (Kolorit, Ikterus, Blass, Turgor) + Haut + AZ + EZ, Perzentilen Abdomen (Quadranten, Auskultation, Loslass-Sz., Meteorismus, Resistenzen, Bruchpforten, Abwehrspannung Lanz/Mc Burney, Courvoisier/Murphy, Leber, Milz, Nieren) Herz, Lunge Nieren Mund Lymphknoten Analinspektion	Schmerzskala (Smileys) PVK + Labor (Hämat., CRP, LK, Hämat., Pankreas-Amylase + -lipase, Bilirubin, ALP, y-GT, Kreatinin, Tropoin, CK-MB) US, EKG, Rx-Leer (stehend od. li-Seitenlage), Thorax (ap stehend) Ev. CT	Säuglingskoliken: Info dass harmlos, ev. Time-Out, Bauchmassage, Fencheltee Unklare Ursache: Verlaufsbeobachtung + Schmerzprotokoll, ev. Ernährungsberatung 80% der Bauch-Sz. bei Kindern funktionell!!!	3-Monats-Koliken (>3h/T. an >3T./Wo + mind. 3 Wo., harmlos, verschwinden nach 3. Mt. meist) GIT (Invagination, GERD, Hernie, Fremdkörper, Zöliakie, Obstipation, Appendizitis, M. Crohn, etc.) Funktionell wenn >12 Wo. redivi. Sz. + kein ZH mit Nahrungsaufnahme/Defäkation, Sz. n. zunehmend; Je näher am Nabel, kaum nachts, diffus, Schilderung komisch; Ängste, Stress, Motilitätsstörung, Hypersensitivität, E., Hormone) Infekt (HWI, Meningitis, O. media...) Urogenitaltrakt: Pyelonephritis, Torsion, Orchitis, Zysten..... Bewegungsapparat, Herz-Lunge
Gastroenteritis	Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe (Blut, Schleim, Farbe, Menge, Konsistenz, Freq.), Fieber, Kopf-Sz., AZ, Bewusstsein, Krämpfe, Ernährung/Trinken, Stuhl + Urin, Umfeld, verdorbene Speisen, Einfuhr vs. Verluste berechnen, Auslandsreisen *Erlittene Verluste (inner 4h mit Orale Hydratationslösung ersetzen), laufende Verluste + Erhaltungsbedarf!	Inspektion (Kolorit, Ikterus, Blass, Turgor/Schleimhäute/ Fontanellen, Bewusstsein) Abdomen (Quadranten, Auskultation, Loslass-Sz., Meteorismus, Resistenzen) Lymphknoten Herz, Lunge Nieren Mund	Monitoring: Atmung, BD, Puls, Bewusstsein Urin/Stuhl in Windeln ansehen Fieber + Gewicht messen <u>Andauernder schwerer GE:</u> Labor (Elektrolyte, Glucose, Laktat, Blutbild, CRP), Urinstatus Erreger-Dx (Stuhlkulturen, Serologien)	1. *Hydratation (Tee + Sirup in kl. Mengen), orale Elektrolyte/Hydratationslösung (4h) 2. Nur kurz Schonkost, schnell wieder normale Nahrung! 3. Antiemetikum/Motilium 4. Immodium (nur wenn dringend nötig >Reisen, Arbeit) 6. Buscopan (wenn Krämpfe) 5. Bioflorin für nach GE Wenn Exsikkose/stark red. AZ >Hospitalisation + i.v. NaCl, i.d.R. keine Indikation f. AB, ausser: blutige Durchfälle (Vd.a. Shigellen), hohes Fieber, Säugling, Alte >Ciprofloxacin	Melden falls Problem mit Hydratation! Dauert 5-7 T., s. ansteckend oft. Schonkost nicht lange! Meist viral, wenn bakt. dann oft hoch Fieber + blutiger Durchfall. Orale Hydratationslösung: H2O + Elektrolyte + Glucose, nur f. die ersten Stunden, dann wieder Shoppen/normale Kost! Stillen nicht unterbrechen.!
Otitis media	s. ORL-ZF				
Verschluckter FK	Siehe ORL				

	Obstipation	Hautfaltenmessung	Serum, ev. Molekulargenet. Tests		Vernachlässigung/Misshandlung
--	-------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------

!!!NICHT VERGESSEN: PA (SS- + Geburtsanamnese), **FA, Medis, Allergien, Soziales/Entwicklung**. Genauer Status + Anamnese siehe CST.